



입원환자 의무기록(POMR)

실습정보

과	분과	병원
소아청소년과	소아청소년과	한양대학교 서울병원
날짜	시간	
2026-07-05	01:28 ~ 01:58	

기본정보

다당교수 (전공의)	필수	선택
나재운		
버전	상태	
1	▼	임시저장

실시간

[임상표현]발열(불명열/고체온증)

환자 정보

유형

의뢰서 미지참 신환

의뢰서 지참신환

구환

타병원에서 전원된 환자

기타

환자이름

연령

성별

병력번호

신**

2

세

남성(M)

031*****

문제 목록

문제번호	기록날짜	문제목록	해결상태
------	------	------	------

실습내용

평가기준

- 필수입력항목: 실습정보, 기본정보, 실습항목, 환자정보
- 입원환자의무기록지(POMR)는 10분에 1번씩 자동 저장됩니다.
- 2개 브라우저나 2개 단말에서 동시 접속하지 않도록 유의해주시기 바랍니다.

[illegible]

Past Medical History

- DM / HTN / Hepatitis / TB: (-/-/-/-)
- 수술력 및 입원력 (-)
- 알레르기 (-)
- Vaccination: up to date
- Developmental history: 정상

I 가족력

고혈압, 가와사키, 심장질환, 자가면역 가족력 없음.

I 사회력

최근 1개월 여행력 (-)

I 체계별 문진(review of system)

General

- * Fever (+)
- * Chills (+)
- * General weakness/ Activity (moderate)
- * Oral intake (moderate)

HEENT

- * Conjunctival injection (+, bilateral, non-suppurative)
- * Red lip (-)
- * Strawberry tongue (-)
- * Throat injection (+/-)
- * Cervical LN (+, bilateral, <2cm)

Respiratory

- * Cough (-)
- * Sputum (-)
- * Dyspnea (-)
- * Hemoptysis (-)

Cardiovascular

- * Chest pain (-)
- * Tachycardia (+)

Gastrointestinal

- * Abdominal pain (+; 금일 아침 onset)
- * Diarrhea (-)
- * Nausea (-)
- * Vomiting (-)
- * Constipation (-)
- * Melena (-)
- * Hematochezia (-)

Urological

- * Frequency (-)
- * Urgency (-)
- * Dysuria (-)

Skin

- * Polymorphous rash (+; 복부, 등, 양팔)
- * BCG site redness (BCGitis) (+)
- * Desquamation (-)
- * Pruritus (-) ; itching motion 없음

Musculoskeletal

- * Hand, foot edema (+)
- * Hand, foot erythema (+)
- * Joint pain / Bone pain (-/-)
- * Muscle weakness (-)
- * Deformity (-)

신체진찰

I 전신 상태

용모	Alert but acutely ill-looking
----	-------------------------------

영양상태	Oral intake: Moderate
------	-----------------------

I 정신 상태

의식	Alert
----	-------

I 신체 계측

체중	16.0	Kg	신장	93	cm
----	------	----	----	----	----

I 활력 징후

체온	38.6도 (16:26)	맥박	146 (16:26)
온	38.9도 (18:17)		
혈압	수축기: 95 mmHg 이완기: 45 mmHg	SpO2	99%

I 피부

Whole body skin rash (+, 전신)
BCG site redness (+)
No itching motion
Desquamation (-)
Pallor/ jaundice (-/-)
Dry skin / coarse texture (-/-)

I 림프절

Palpable cervical LN (+, bilateral, <2cm)

I 두부

이상 소견 없음.

I 안면

이상 소견 없음.

I 눈

Bilateral conjunctival injection (+, non-exudative)

I 귀

이상 소견 없음.

I 코

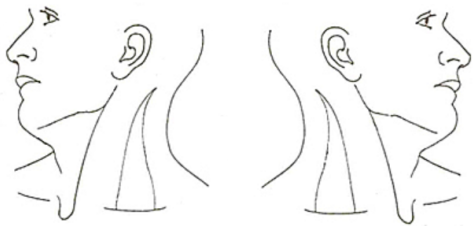
이상 소견 없음.

I 구강 및 인후

Red lip (-)
strawberry tongue (-)
Mild pharyngeal injection (+)
Cervical lymphadenopathy (+, 양측 <2cm)

I 경부

아래 그림을 클릭하면 이미지 편집이 가능합니다.



palpable cervical LN (+, bilateral, <2cm)

I 유방

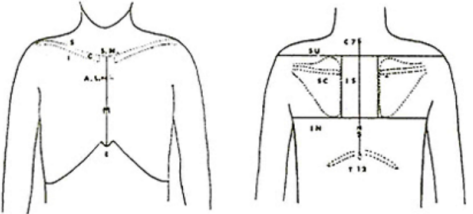
특이소견 없음.

I 호흡기계

Lung sound: clear
No crackles or wheezing

I 흉곽 및 폐

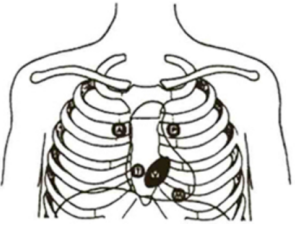
아래 그림을 클릭하면 이미지 편집이 가능합니다.



이상 소견 없음.

I 심혈관 계

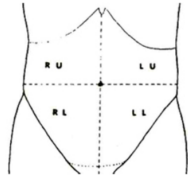
아래 그림을 클릭하면 이미지 편집이 가능합니다.



Tachycardia (PR 146/min)
Normal heart sounds w/o murmurs

I 복부

아래 그림을 클릭하면 이미지 편집이 가능합니다.



Mild tenderness (+)
 Soft, non-distended
 Normal bowel sounds
 Palpable liver/spleen/mass (-/-/-)

I 배부

Skin rash (+)

Deformity (-)

I 생식기 및 직장 수치 검사

이상 소견 없음.

I 사지

Both hand and foot edema/erythema (+/+)

Desquamation (-)

I 골관절

이상 소견 없음.

I 신경계

Alert

I 단서 목록 (Problem Cue List)

- Persistent fever
- Acute ill-looking appearance
- Bilateral non-exudative conjunctival injection
- Edema and erythema of both hands and feet
- Polymorphous rash of the whole body, non-pruritic, including BCGitis
- Cervical lymphadenopathy
- Abdominal pain
- Pharyngeal injection
- GAS Ag positive
- Stool PCR positive for norovirus and adenovirus

I 초기 평가(Initial Assessment)

#1. Kawasaki disease - a, b, c, d, e, f, g

#2. r/o Infection

#2-1. r/o GAS infection / scarlet fever - a, b, e, f, h, i

#2-2. r/o Adenovirus infection - a, c, e, f, g, h, j

#2-3. r/o Norovirus gastroenteritis - a, g, j

#3. r/o Multisystem Inflammatory Syndrome in Children — a, b, c, d, e, f, g

I 초기 계획(Initial Plan)

#1. Kawasaki disease — a, b, c, d, e, f, g, h

Diagnostic Plan

- Inflammation marker f/u: CBC with differential, ESR, CRP, Serum amyloid A
- Evaluation for organ involvement: LFTs (AST/ALT/ALP), total bilirubin, albumin, total protein, Na, NT-proBNP, ketone bodies
- Echocardiography: coronary artery diameter & Z-score, pericardial effusion, ventricular function, valvular regurgitation
- Chest X-ray
- F/U for oral changes, periungual desquamation

Therapeutic Plan

- IVIG 2 g/kg single infusion
- Aspirin 30-50 mg/kg/day → 해열 후 low-dose 3-5 mg/kg/day once daily
- If persistent/recurrent fever 36 hrs after IVIG completion: 2nd IVIG 2 g/kg or steroid or infliximab
- Fever control: acetaminophen, NSAID if high fever persists, IV hydration

Educational Plan

- 아스피린 교육: 출혈 징후, 인플루엔자/수두 감염 시 Reye 증후군 가능성 및 인플루엔자 백신 접종 필요성
- 생백신(MMR, 수두) 지연접종 안내 (고용량 IVIG 후 약 11개월)

#2-1. Streptococcal / Staphylococcal toxic shock syndrome — a, b, c, d, e, h, i

Diagnostic Plan

- V/S & perfusion assessment
- Blood culture and culture of throat/skin/soft tissue
- Multiorgan involvement: Cr/BUN, LFTs, platelet/PT/aPTT/fibrinogen, CK, lactate

Therapeutic Plan

- Aggressive fluid resuscitation
- Empirical antibiotics: 의심균에 따라 penicillin + clindamycin 또는 vancomycin/clindamycin 사용
- Consider adjunctive IVIG in severe cases

Educational Plan

- 약화 징후(처짐, 사지 냉감, 소변 감소) 교육

#2-2. Scarlet fever (GAS) — a, b, e, f, h, i

Diagnostic Plan

- Throat swab RADT and culture
- Assess clinical signs: sandpaper rash, Pastia's lines, circumoral pallor, strawberry tongue, tonsillar exudate

Therapeutic Plan

- If true GAS: amoxicillin 50 mg/kg/day (max 1,000 mg) or penicillin V for 10 days

Educational Plan

- 효과적 항생제 24시간 후 전염력 소실, 류마티스열 예방 위해 완주
- KD 공존 시 항생제로 해열 안 될 수 있음 설명

#2-3. Adenovirus infection — a, c, e, f, g, h, j

Diagnostic Plan

- Nasopharyngeal respiratory virus PCR panel
- Observe exudative pharyngitis, conjunctivitis with discharge, preauricular lymphadenopathy, cough

Therapeutic Plan

- Supportive care (antipyretics, hydration), contact precautions

Educational Plan

- 자연 호전, 대증치료, 손위생으로 전파 예방

#2-4. EBV infectious mononucleosis — a, e, f, h

Diagnostic Plan

- CBC with differential (atypical lymphocytes), LFTs
- EBV-specific serology (VCA IgM/IgG, EBNA)
- Look for exudative pharyngitis, posterior cervical lymphadenopathy, hepatosplenomegaly

Therapeutic Plan

- Supportive care; avoid amoxicillin/ampicillin
- Restrict contact/collision activity if splenomegaly

Educational Plan

- 피로 수주 지속 가능, 비장 보호 주의, aminopenicillin 회피 안내

#2-5. Measles — a, c, e

Diagnostic Plan

- Confirm MMR vaccination history, check for Koplik spots
- Measles IgM + RT-PCR (nasopharyngeal/throat swab ± urine)

Therapeutic Plan

- Supportive care + vitamin A ×2 doses (24 hrs apart), ≥12 months 200,000 IU
- Airborne isolation (negative-pressure room, N95), until 4 days after rash onset

Educational Plan

- 격리 이유, 감수성 접촉자 PEP, 이후 MMR 완료 안내

#2-6. Norovirus gastroenteritis — a, g, j

Diagnostic Plan

- Monitor hydration status, I/O, electrolytes

Therapeutic Plan

- Supportive care (oral/IV hydration),

Educational Plan

- 손위생/접촉주의, 임상적으로는 incidental shedding 가능성 높음 설명

#3. r/o MIS-C — a, b, c, d, e, f, g

Diagnostic Plan

- SARS-CoV-2 PCR/antigen + nucleocapsid serology, history of infection/exposure in prior 2–6 weeks
- Inflammation/organ markers: CRP, ferritin, D-dimer, fibrinogen, troponin, NT-proBNP
- Echocardiography, EKG, LFTs, CBC, coagulation panel

Therapeutic Plan

- If confirmed MIS-C: IVIG ± corticosteroid (first-line), aspirin, biologics if refractory
- Cardiac monitoring, risk-based antithrombotic therapy

Educational Plan

- COVID 연관 과염증 설명

I 경과기록

HD #1 (2026-06-29)

S	"열도 안 떨어지고 발진도 새로 생겨서 걱정돼요" (모)
O	V/S: Lab findings - CBC: Seg neutrophil 86.4%▲, lymphocyte 8.3%▼, Hb 10.9▼ / Hct 31.9▼ - Inflammation: CRP 15.09▲, ESR 22▲, Serum amyloid A >300▲, Procalcitonin 0.77▲ - Organ involvement: AST 87▲ / ALT 220▲ / ALP 295▲, total bilirubin 2.12▲, albumin 3.1▼, total protein 5.6▼ - Cardiac: NT-proBNP 3752.9▲ - Others: ketone body 290.4▲ - Venous blood gas: mild metabolic acidosis (pH 7.33, HCO₃ 20.6, BE -4.9, lactate 1.3) - UA (1st, 17:23): WBC many/HPF, nitrite (+), leukocyte 2+, protein 2+, bilirubin 2+, bacteria a few → pyuria CXR: diffuse bronchitis & bronchopneumonia, both lungs EKG monitoring: arrhythmia (-)
A	#1. Kawasaki disease #2. r/o Infection (bacterial/viral) #3. r/o MIS-C / toxic shock / drug eruption #4. Ketosis with mild metabolic acidosis d/t poor oral intake and acute febrile illness
P	진단 Echocardiography (coronary artery Z-score, pericardial effusion, ventricular function, valvular regurgitation) Abdomen and neck sono Blood culture Urine culture Respiratory virus PCR Mycoplasma pneumoniae antibody cervical LN 재촉진 치료 1st IVIG 2 g/kg (34.8g) 시작, EKG monitoring High-dose aspirin 경험적 IV cefotaxime IV hydration, fever control (acetaminophen, 고열 시 ibuprofen) 교육 IVIG 투여 중 arrhythmia, chills 등 이상반응 시 알리도록 설명 아스피린 관련 출혈 징후 관찰 교육

HD #2 (2026-06-30)

S	"저녁에 배 아프다고 했어요" (보호자)
O	Fever (+) Improved skin rash, BCGitis Persistent both hand and foot swelling UA (2nd, 09:03): WBC many/HPF, nitrite (-), bacteria not seen, leukocyte 1+, protein 1+, bilirubin 1+ Abd sono: Enteritis with ascites, diffuse periportal & pericholecystic edema, GB sludge, cystitis Neck sono: both neck level II~IV enlarged lymph nodes (AP diameter up to 0.9cm)
A	#1. Kawasaki disease with GI involvement, currently on IVIG and aspirin #2. r/o Infection
P	진단 Echocardiography (coronary artery Z-score) 발열 지속 여부 및 IVIG 반응성 재평가 (종료 후 36시간 시점) 치료 High-dose aspirin, IV cefotaxime, IV hydration, fever control 유지 발열 재발 시 IVIG 저항성 고려하여 2차 치료 준비 교육 Rt hand IV 부위 감염 예방 위해 물 당지 않도록 교육 발열, 복통 등 증상 악화 시 즉시 알리도록 설명

HD #4 (2026-07-02)

S	-
O	Fever (+), 해열제에도 반복 발열 Persistent conjunctival injection Persistent both hand and foot edema/o Ketosis Skin rash, BCGitis 거의 소실됨 stomatitis (-), strawberry tongue (-) Abdominal distension (+) Echocardiography: small coronary aneurysm, mild MR Lab f/u - Albumin 2.1▼, total protein 6.0, ESR 32▲, Hb 10.4▼ - CRP 12.16▲, Serum amyloid A 82.3▲, NT-proBNP 2487.6▲ - Procalcitonin 0.57, ketone body 753.4▲ - CK-MB 1.0, Troponin-I <0.010 Urine culture : Gram stain no organism, WBC 20~29/HPF anti-mycoplasma Ab negative
A	#1. IVIG-resistant Kawasaki disease with small coronary aneurysm and mild MR #2. Ketosis d/t poor oral intake #3. Hypoalbuminemia with edema, third spacing
P	진단 EKG monitoring Lab, echocardiography f/u 치료 2nd IVIG 2 g/kg (34.8g) Methylprednisolone pulse, for 3 days (predisol 500mg) High-dose aspirin, IV cefotaxime, IV hydration, fever control 유지 교육 steroid pulse 중 arrhythmia, hypertension, hyperglycemia 등 부작용 monitoring 필요성 설명 2차 치료 목적(관상동맥 합병증 진행 억제) 및 입원 지속 필요성 설명

HD #5 (2026-07-03)

S	"컨디션도 많이 괜찮아지고 먹는 것도 좋아졌어요, 붓기도 많이 빠져서 신발도 잘 맞아요" (보호자)
O	Fever (-) (36~37.2℃) EKG monitoring 중 arrhythmia(-) BST 158 mg/dL Improved both foot swelling
A	#1. IVIG-resistant Kawasaki disease with small coronary aneurysm and mild MR
P	진단 mPD pulse 중 v/s 및 EKG monitoring, BP/BST 추적 지속 퇴원 전 lab, echocardiography f/u 치료 mPD pulse #3/3 High-dose aspirin, IV cefotaxime, IV hydration 유지 교육 ambulation 권장 steroid 부작용(고혈당, 고혈압) 및 특이증상 시 알리도록 설명

HD #7 (2026-07-05, 퇴원)

S	"컨디션, 밥먹는 것 다 괜찮아졌어요"(보호자)
O	Fever (-) (36.4~37.1℃) both hand, foot edema 호전
A	#1. IVIG-resistant Kawasaki disease with small coronary aneurysm and mild MR
P	진단 외래 lab, echocardiography f/u 치료 퇴원 및 저용량 aspirin 전환 교육 퇴원 후 39℃ 이상 발열 시 ER 내원하도록 교육 외래 방문 전까지 어린이집 등원 자제 아스피린 복용 중 출혈 징후 관찰, 인플루엔자/수두 감염 시 Reye 증후군 주의 생백신(MMR, 수두)은 IVIG 후 약 11개월 지연 접종 안내 손발끝 낙설은 회복기 정상 소견임을 설명

제출

수정

증례발표 생성

삭제

2021050782_E4_이단비_소아청소년과_A파트_disease review (1).pptx

목록으로

삭제

증례발표 생성

수정

제출

